



FORMULÁRIO ESPECÍFICO – HAP

1	NOME CIVIL DO(A) PACIENTE: NOME SOCIAL DO(A) PACIENTE:									
2	DATA DE NASCIMENTO: / /									
3	CID-10:									
4	4.1 HIPERTENSÃO PULMONAR – INDICAR GRUPO: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V 4.2 INFORMAR: <table border="1"><tr><td>Paciente possui fatores de risco ou dados ecocardiográficos compatíveis com doenças do coração esquerdo como causa de HP?</td><td>SIM ☐</td><td>NÃO ☐</td></tr><tr><td>Paciente possui exames compatíveis com doenças pulmonares crônicas como causa de HP?</td><td>SIM ☐</td><td>NÃO ☐</td></tr><tr><td>Paciente possui exames compatíveis com embolia pulmonar como causa de HP?</td><td>SIM ☐</td><td>NÃO ☐</td></tr></table>	Paciente possui fatores de risco ou dados ecocardiográficos compatíveis com doenças do coração esquerdo como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐	Paciente possui exames compatíveis com doenças pulmonares crônicas como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐	Paciente possui exames compatíveis com embolia pulmonar como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐
Paciente possui fatores de risco ou dados ecocardiográficos compatíveis com doenças do coração esquerdo como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐								
Paciente possui exames compatíveis com doenças pulmonares crônicas como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐								
Paciente possui exames compatíveis com embolia pulmonar como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐								
5	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EVOLUÇÃO DA DOENÇA: O paciente apresenta dispneia progressiva aos esforços há aproximadamente seis meses, associada a fadiga intensa e edema de membros inferiores, com piora clínica recente importante e necessidade de avaliação especializada urgente para definição terapêutica.									
6	CATETERISMO CARDÍACO DIREITO: Data: / / ☐ PAPm: ☐ POAP ou PDFVE: ☐ RVP Wood: PAPm: pressão arterial pulmonar média; POAP: pressão de oclusão da artéria pulmonar; PDFVE: pressão diastólica final do ventrículo esquerdo; RVP: resistência vascular pulmonar									
7	INFORMAR ETIOLOGIA DA DOENÇA: ☐ 7.1 HAP Idiopática, hereditária ou induzida por drogas. 7.1.1 Caso assinalado o item acima, indicar: TESTE DE REATIVIDADE COM ÓXIDO NÍTRICO: ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO Justificativa para não realização do teste: OU ☐ 7.2 HAP associada 7.2.1 Caso assinalado o item acima, indicar enfermidade associada: ☐ Colagenoses, ☐ Hipertensão Porto-pulmonar ☐ Esquistossomose ☐ HIV ☐ Cardiopatia congênita ☐ Venó-oclusiva									



8	MEDICAMENTOS SOLICITADOS: <table border="1"><thead><tr><th>Medicamentos solicitado</th><th>Posologia</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ Ambrisentana</td><td></td></tr><tr><td>☐ Bosentana</td><td></td></tr><tr><td>☐ Sildenafil</td><td></td></tr><tr><td>☐ Iloprosta</td><td></td></tr></tbody></table>	Medicamentos solicitado	Posologia	☐ Ambrisentana		☐ Bosentana		☐ Sildenafil		☐ Iloprosta	
Medicamentos solicitado	Posologia										
☐ Ambrisentana											
☐ Bosentana											
☐ Sildenafil											
☐ Iloprosta											
9	RISCO ESTRATIFICADO (CONFORME PCDT): ☐ RISCO BAIXO ☐ RISCO INTERMEDIÁRIO ☐ RISCO ALTO Detalhar: 										
10	CLASSE FUNCIONAL (NYHA/WHO-FC): ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV										
11	O PACIENTE APRESENTA ALGUMA DAS SITUAÇÕES DESCRITAS ABAIXO? <table border="1"><tbody><tr><td>Doença hepática grave</td><td>SIM ☐ NÃO ☐</td></tr><tr><td>Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar</td><td>SIM ☐ NÃO ☐</td></tr><tr><td>Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)</td><td>SIM ☐ NÃO ☐</td></tr><tr><td>Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia</td><td>SIM ☐ NÃO ☐</td></tr><tr><td>Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC</td><td>SIM ☐ NÃO ☐</td></tr></tbody></table>	Doença hepática grave	SIM ☐ NÃO ☐	Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar	SIM ☐ NÃO ☐	Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)	SIM ☐ NÃO ☐	Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia	SIM ☐ NÃO ☐	Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC	SIM ☐ NÃO ☐
Doença hepática grave	SIM ☐ NÃO ☐										
Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar	SIM ☐ NÃO ☐										
Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)	SIM ☐ NÃO ☐										
Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia	SIM ☐ NÃO ☐										
Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC	SIM ☐ NÃO ☐										



12	EXAMES COMPLEMENTARES:		
	Exames complementares	Data	Resultado
	Ecocardiograma		
	Eletrocardiograma		
	Espirometria		
	Teste de caminhada de 6 minutos (T6MC)		
	Polissonografia/Oximetria Noturna*		
	Angiotomografia de tórax ou Cintilografia Pulmonar de Perfusão		
	Ultrassonografia abdominal		
	Gasometria arterial		
	Radiografia de Tórax		
Nyha: new york heart association. Who: world health organization. Fc: functional classification * Reservado aos pacientes com sintomatologia da síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono (sahos).			
13	OUTRAS OBSERVAÇÕES PERTINENTES:		
14	Assumo integral responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.		
Data de preenchimento: / /			
Assinatura e carimbo: _____			
Médico			